

3

PREGUNTAS A ESPECIALISTAS

// URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS E INTOXICACIÓN POR DROGAS DE USO RECREATIVO

// DRA. MARTA BRASCHI*

Médica Especialista en Pediatría y Toxicología. Docente UBA.
Médica Pediatra Hebiatra y Toxicóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Miembro del Equipo de Dispositivo Pavlovsky.
Miembro del Grupo de Trabajo en Adicciones de SAP.

// DRA. YEMINA MARZETTI*

Médica Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil.
Especialista Universitaria en Psiquiatría.
Docente Universidad Nacional de Cuyo.
Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Médicas, UNCuyo.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar

OBJETIVOS

- ◆ Identificar la necesidad de organizar la atención en guardia de los pacientes que ingresan con situaciones relacionadas con la salud mental.
- ◆ Realizar la evaluación de triage aplicando el código de 5 colores para diferenciar situaciones de distintos grados de complejidad y urgencia.
- ◆ Reconocer las situaciones clínicas más comunes de los problemas de salud mental en un servicio de urgencias.
- ◆ Abordar los episodios de excitación psicomotriz en niños, niñas y adolescentes.
- ◆ Identificar en la guardia los factores de riesgo de suicidio con el triage y la evaluación clínica.
- ◆ Enumerar los criterios de internación frente a un paciente que ingresa con intento de suicidio.
- ◆ Describir la conducta a asumir frente a un paciente que ingresa a la guardia con un cuadro clínico asociado al consumo de sustancias recreativas.

Agradecimientos:

Dra. Beatriz Cáceres, Dra. Sabrina Davenia, Dr. Juan Carlos Castellanos



INTRODUCCIÓN

El incremento de las urgencias pediátricas y en adolescentes relacionadas con la salud mental ha sido continuo en la última década, presentando un aumento significativo luego de la Pandemia Covid-19.

Las presentaciones clínicas de la **urgencia en salud mental frecuentemente derivan de:**

- ✓ La descompensación de un trastorno mental ya diagnosticado.
- ✓ Insuficiente contención en momentos de crisis vitales.
- ✓ Condiciones adversas del contexto social y/o familiar.

Los cuadros clínicos asociados al consumo de sustancias recreativas son otra causa frecuente de consulta en los servicios de guardia. Las problemáticas de consumo de sustancias son más frecuentes en la adolescencia, sin embargo, aparecen en todas las etapas de la niñez y adolescencia y también pueden estar asociadas a consumo parental. En los últimos años se presenta un descenso en la edad de inicio de consumo tanto de sustancias como de adicciones conductuales (juegos online, redes sociales, apuestas, etc.). En los servicios de guardia se reciben, con frecuencia, intoxicaciones secundarias a intentos autolíticos (tanto con fármacos como con tóxicos).

Las situaciones que vemos en emergencias suceden en contextos de vulnerabilidad social y de derechos, presentamos algunos datos de la **Encuesta sobre la Situación de niños niñas y adolescentes UNICEF 2023 - 8° reporte, 2024.**

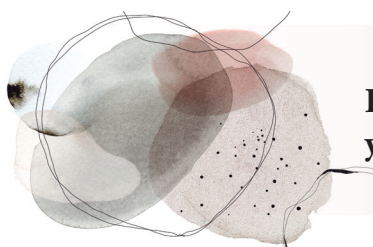
- ✓ En el 48% de los hogares, los ingresos mensuales son insuficientes para cubrir sus gastos corrientes. Representan a más de 3 millones de hogares.
- ✓ El 52% de los hogares, por falta de dinero, han tenido que dejar de comprar algún alimento.
- ✓ Durante el último año, se registró que aproximadamente un cuarto de las y los adolescentes realizaba tareas laborales y que un 12% buscaba trabajo.
- ✓ En un 35% de los hogares, sus integrantes dejaron de realizar consultas médicas y/o con el dentista y en un 23% dejaron de comprar medicamentos.
- ✓ Las preocupaciones de los más jóvenes están relacionadas con el contexto:
 - La pobreza es el ítem más mencionado de 44%.
 - El trabajo pasó del 28% en 2023 al 30% en el período consultado. La búsqueda de trabajo entre las y los adolescente asciende a un 22% en los hogares en donde las chicas y chicos se saltean comidas. Se reduce a menos del 5% en hogares con jefe registrado en la seguridad social.
 - Un 18% de los adolescentes que buscan trabajo NO asisten a la escuela.
- ✓ La educación dio un salto importante, le preocupa a un 29%, cuando el año anterior lo señaló el 19%. En este sentido, el 6% de los adolescentes advirtió que no sabe si terminará la escuela secundaria, sobre todo en los hogares donde vive el 40% más pobre, los hogares endeudados y en aquellos donde se saltean comidas.

Las **urgencias hospitalarias** suelen ser la puerta de entrada del paciente a la red de salud mental. Una adecuada valoración y orientación inicial, un trato empático y respetuoso facilitará la adherencia terapéutica posterior que será clave en la evolución del paciente.

Los servicios de urgencia deben disponer de profesionales preparados y en el marco de la Ley de Salud Mental, debe brindarse atención de salud mental en hospitales generales, lo que implica robustecer los equipos interdisciplinarios a fin de brindar una atención adecuada.

✓ ¿Qué entendemos por urgencia psiquiátrica en niños/as y adolescentes?

La urgencia en salud mental es toda situación transitoria que irrumpe y altera las funciones psíquicas, el desempeño habitual y que supone un alto nivel de padecimiento, de tal manera que la persona, el entorno y/o el personal sanitario, consideran que requiere atención inmediata.

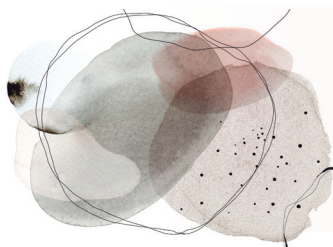


Implica una crisis que puede tener causas orgánicas, psíquicas y/o sociales y constituye una ruptura del equilibrio vital.

Se define por la necesidad de un tratamiento inmediato por situaciones de sufrimiento psíquico con alteraciones agudas y graves.

Es frecuente encontrar que los pacientes pediátricos y adolescentes colaboran poco al momento de la evaluación en guardia y que sean los padres o cuidadores acompañantes quienes evalúen la consulta como “urgente”, en este sentido hay que considerar que la situación también podría responder a su nivel de tensión emocional o dificultad para resolver el problema actual. Es muy importante brindar una atención empática con los adultos a cargo y poder generar un clima de confianza para la evaluación del paciente.

Las urgencias de salud mental se presentan en todo contexto y dispositivo asistencial, y la mayoría de las veces son los profesionales no especializados/as en salud mental los responsables del abordaje inicial.



Es prioritario destacar que antes de la evaluación mental, hay que realizar una valoración médica completa con despistaje de patología orgánica subyacente.

En la evaluación de salud mental se debe determinar el nivel de atención que requiere un paciente determinado, que puede ser, el ingreso en una unidad de hospitalización psiquiátrica o una unidad de intervención en crisis o la derivación a los sistemas de Salud Mental ambulatoria.

✓ ¿Cómo se organiza la atención en la guardia de los padecimientos de salud mental?

En el primer abordaje de las urgencias, por parte del equipo no especializado, en paralelo al abordaje clínico deben realizarse intervenciones mínimas vinculadas a la situación de salud mental que se presente. Es importante evitar pausar las intervenciones sobre la situación de urgencia, inclusive en los casos en los que el acceso al equipo de salud mental tenga demoras propias del sistema.

El primer encuentro con personal sanitario no administrativo es en la **evaluación de Triage**.

El **código de cinco colores** diferencia situaciones de distintos grados de complejidad y urgencia. En el triage se mencionan los tiempos esperados desde el ingreso del usuario al servicio hasta llegar al médico no especializado. Estos tiempos se basan en propuestas internacionales y su importancia radica en la comparativa con los tiempos propuestos para los usuarios con padecimientos de salud en general.

Tabla 1. Niveles de atención de urgencias en salud mental

Nivel/Tiempo hasta el médico	Denominación	Código	Condición
1. Inmediato	Emergencia	Rojo	Condición orgánica + Síntomas psiquiátricos: encefalitis, ACV, crisis epiléptica, Sd. Confusional/delirium, intoxicaciones o efectos adversos graves y abstinencias graves, lesiones graves. Se le observa confundido o incapaz de cooperar.
2. 10 min	Muy urgente	Naranja	Excitación psicomotriz (EPM), auto/heteroagresividad manifiesta (verbal o física), intoxicaciones o efectos adversos moderados, distonía aguda, intento o amenaza de suicidio, amenaza de dañar a terceros.
3. 30 min	Urgente	Amarillo	Ideación suicida activa, inquietud psicomotriz no agresiva, síntomas maníacos, comportamientos disruptivos, alucinaciones, ideas delirantes, conductas desorganizadas/bizarrias, mutismo, ataques de pánico, dependencia de sustancias, intoxicación o efecto adverso leve, abstinencia, trastorno conversivo o trastorno de síndrome somático funcional (SSF).
4. 60 min	Poco urgente	Verde	Síntomas de ansiedad o depresión sin ideación suicida, problemática de consumo sin dependencia, sin intoxicación aguda o abstinencia, hostilidad o negativismo sin conductas de riesgo.
5. 120 min	No urgente	Azul	Urgencia subjetiva que no presente las manifestaciones previamente mencionadas, solicitud de medicación, vulnerabilidad.

Fuente: Protocolo provincial de manejo inicial de las urgencias en salud mental – Mendoza 2023.

Por ejemplo, se puede observar como el código rojo (emergencia) está reservado para casos con complicaciones clínicas asociadas. Los pacientes con código amarillo en adelante deben ser evaluados eventualmente por un equipo especializado de salud mental, sin discontinuar la asistencia de guardia. En los hospitales que cuentan con equipo de salud mental la decisión de la internación queda a su cargo. Las situaciones de bajo riesgo (verde y azul), pueden ser asesoradas adecuadamente y derivadas por profesionales de urgencia no especialistas en salud mental.

✓ ¿Cuáles son los puntos claves en la evaluación integral del niño/a o adolescente en situaciones de urgencias?

• Consideraciones Generales

Durante la entrevista con el/la paciente y/o referentes vinculares se **evalúa el aspecto general y la presentación** (cómo llega, con quién, en qué condiciones de aspecto general de acuerdo a su ámbito sociocultural).

Se realiza un **examen físico** general y tener en cuenta los siguientes signos:

- ✓ La inspección de las pupilas (midriáticas, mióticas, anisocoria).
- ✓ Frecuencia cardíaca y amplitud de pulsos (taquicardia, bradicardia).
- ✓ Tensión arterial.
- ✓ Temperatura corporal (la hipotermia se vincula a alcohol y depresores, la hipertermia a estimulantes y alucinógenos).
- ✓ Humedad en piel y mucosas (sudoración, sialorrea sequedad).
- ✓ Estado de hidratación, diuresis (descartar globo vesical).

Evaluar la posibilidad de embarazo (según corresponda), signos de abuso sexual/maltrato, signos de autolesión/intento de suicidio y signos físicos de consumo nocivo de sustancias psicoactivas (alcohol y otras drogas).

Es de suma importancia **identificar los posibles desencadenantes** de la crisis indagando el contexto en el que ocurre, cambios en las costumbres y usos cotidianos o cualquier acontecimiento estresante en curso. Tener en cuenta antecedentes de episodios similares y/o tratamientos previos y antecedentes familiares.

En niños/as se ofrece un lugar para jugar y/o dibujar ya que son medios privilegiados para el abordaje en las infancias.

• Evaluación clínica / toxicológica inicial

Aunque el consumo de sustancias suele estar vinculado al adolescente, hoy en día podemos encontrar estas intoxicaciones en las diferentes etapas de la vida y en la consulta pediátrica debe sospecharse como origen de síntomas en pacientes.

La **entrevista clínico-toxicológica** consta de una anamnesis dirigida, empática, no judicativa manteniendo la escucha activa en un espacio de privacidad.

Es importante estar al corriente de los hábitos más comunes en la adolescencia para poder abordarlos y poder preguntar sobre las sustancias que pudieran estar involucradas y con respecto a los retos de las diferentes redes sociales, también explorar la posibilidad de la intervención en alguno de ellos.

Las **preguntas son:** ¿Tomás? ¿Qué tomas? ¿Con qué frecuencia? ¿Cantidad? ¿Solo/a o acompañado/a? ¿Si no tomas qué te pasa? ¿Trataste de dejar? ¿Fumas? ¿Qué fumas? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué edad empezaste? ¿Qué más probaste? ¿Tuviste problemas con el consumo? ¿Tenes momentos en que no te acordás que hiciste? ¿Tus amigos y tu pareja también consumen? ¿Alguien te dijo que estas pasándote con el consumo?

Evaluar si conduce o hace **actividades riesgosas** en consumo, episodios de blackout (amnesia lacunar secundaria a consumo de sustancias), mezclas de sustancias, exposición a relaciones sexuales no consensuadas o episodios de violencia.

En los casos en que el paciente tenga el estado de conciencia alterado, se recomienda entrevistar al acompañante quien puede orientarnos sobre la situación y espacio previo al ingreso.

✓ ¿Cuáles son las situaciones clínicas más comunes de los problemas de salud mental en un servicio de urgencias en los países de nuestra región?

- Episodios de excitación psicomotriz.
- Intentos de suicidio.
- Trastornos conductuales.
- Cuadros asociados al abuso de sustancias.
- Episodios de auto y heteroagresión.
- Crisis de ansiedad.
- Episodios psicóticos agudos.

A continuación, se presentarán algunas **situaciones clínicas y un resumen de su abordaje**.

ARIEL, 6 AÑOS

Ariel concurre al servicio de guardia de un hospital pediátrico de alta complejidad.

Nacido de embarazo y parto normal, sin antecedentes de enfermedades graves, quien a partir de los 3 años se encuentra en seguimiento por alteraciones del desarrollo, lenguaje y comunicación. Se realizó el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Actualmente presenta una crisis de excitación psicomotriz y fue derivado por su psiquiatra por agravamiento de conductas disruptivas en las últimas semanas y respuesta parcial a tratamiento psicofarmacológico. Estudios complementarios realizados RMN de cerebro, normal. EEG pendiente.

Su padre refiere que hace dos semanas se agravaron las conductas disruptivas y se probaron sin éxito distintos esquemas psicofarmacológicos, la crisis actual coincide con el inicio de una nueva medicación (clomipramina).

Plan farmacológico al momento de la consulta por guardia: clomiprimina 25 mg/día, oxcarbamazepina 600 mg/día y levomepromazina 25 mg/día. No refiere enfermedades asociadas en este momento.

Se decide internación por salud mental por agravamiento del cuadro. Se solicita EEG, y analítica completa.

Al examen físico se evidencian piezas dentales en mal estado y dolor asociado. Se suspende ox-carbazepina, levomepromazina y clomipramina. Se instaura haloperidol en gotas y difenhidramina como plan terapéutico en la guardia. Se deriva para tratamiento odontológico.

✓ ¿Qué es un episodio de excitación psicomotriz?

El episodio de excitación psicomotriz (EPM), surge en respuesta a una tensión interna y se traduce en un aumento inadecuado en la actividad motora y marcada inestabilidad emocional, es decir la persona no puede emocionalmente regular la angustia, o el estado de ánimo. Se presenta con inquietud psicomotriz, irritabilidad, mayor reacción ante estímulos y conductas inapropiadas sin finalidad coherente, que pueden traducirse en actividades destructivas y violentas.

Este cuadro puede ser de:

- **intensidad leve**, se denomina inquietud psicomotriz, o de
- **gran intensidad** llegando a ser una agitación extrema con tempestad de movimiento, este último se trata de un cuadro incontenible, en el que ni el niño o el adolescente, ni su familia, pueden controlar su conducta.

Cuando el EPM está vinculado a sustancias se debe sospechar consumo de: cocaína, metanfetaminas, nuevas sustancias psicoactivas (NSP), anfetaminas, cannabinoides sintéticos o cannabis con elevada concentración de tetrahidrocannabinol (THC).

✓ ¿Cuáles son los puntos a considerar para evaluar un episodio de EPM en niños y adolescentes?

1. **Edad del paciente:** Cada edad presenta cuadros característicos que se interpretan de forma particular. La diferencia se basa en las características propias del desarrollo de cada grupo, el nivel de desarrollo del lenguaje, de la capacidad de expresión verbal y del proceso de pensamiento, la modalidad y la capacidad de respuesta ante estresores típicos de cada edad. A menor edad, el niño es más dependiente de situaciones medioambientales y familiares, por lo tanto, en niños pequeños la primera intervención es sobre el medio familiar y descartar causas médicas frecuentes que puedan causar dolor.
2. Si el **episodio es agudo** "de novo" o es parte de un problema crónico de salud mental ya estudiado y/o tratado.
3. Si hay **antecedentes** de trastornos del desarrollo o trastornos conductuales.
4. Si el EPM apareció luego de un **evento potencialmente traumático**.
5. Si hay **problemas médicos relacionados**.
6. Si hay **cuadros neurológicos**.
7. Si el cuadro puede corresponder al **consumo** por uso y abuso de alcohol, de fármacos o de sustancias.

8. Determinar si existe **riesgo** cierto inminente para sí o para terceros.
9. Evaluar la **necesidad de hospitalización** que, en el caso de consumo de sustancias, siempre es conveniente para evaluación clínica.

✓ ¿Cómo se realiza el abordaje de los cuadros de excitación psicomotriz?

Teniendo en cuenta la complejidad que presupone un paciente agitado hay que recordar la **tríada básica para su abordaje**:

- ✓ Medidas de seguridad.
- ✓ Contención.
- ✓ Evaluación de la causa.

Una de las primeras medidas ante un paciente con EPM es evaluar si existe **riesgo cierto e inminente** (entiéndase a aquellas contingencias que puedan desencadenar un daño que amenace o cause un perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros) y tomar las medidas de seguridad apropiadas para el paciente y el profesional de la salud. Solo se debe proceder cuando esté garantizada la seguridad del profesional.

Ante la sospecha de consumo de sustancias la hidratación y el uso de benzodiazepinas y control clínico y laboratorio son fundamentales para asegurar una buena evolución. Ante un cuadro de delirio agitado por sustancias la desescalada de violencia, el uso de benzodiazepinas y por último la contención física es fundamental para la supervivencia del paciente.

El uso de benzodiazepinas está recomendado a partir de los 12 años. En edades menores se incrementa el riesgo de cuadro paradójico. Las más utilizadas son las de acción corta como el lorazepam. En EPM en niños menores de 12 años, se puede evaluar el uso de difenhidramina, levomepromazina o haloperidol según la gravedad de la crisis y luego de evaluar que no se presenten contraindicaciones. Siempre se inicia y se prioriza la vía oral.

MACARENA, 14 AÑOS

Esta adolescente concurre a consulta clínica, por presentar un cuadro gastrointestinal, se encuentra acompañada por su madre. Es evaluada por el pediatra de guardia. Durante el examen físico el profesional identifica cortes superficiales en ambos antebrazos. Generando un clima de confianza y ambiente tranquilo conversa con Macarena y la paciente expresa que había estado cortándose durante el último año, que lo hacía cuando su estado de ánimo era bajo, negaba querer morir, sin embargo, continuaba con los cortes que eran cada vez más profundos.

Confesó tener ideas de autolesionarse, con un incremento reciente en frecuencia e intensidad y que estaba sufriendo bullying en el colegio. A pesar de estos síntomas su desempeño no se veía afectado, llevaba bien el colegio.

Afirmaba cortarse para aliviar tensiones y evitar sentimientos de soledad. Negó usos de tóxicos y de alcohol. Hace un mes contó esta situación a sus padres, quienes buscaron ayuda psicológica

para ella que no se había efectivizado al momento. Presenta buena relación con sus padres, y la describen como una hija tranquila y buena estudiante.

✓ ¿Cuál es el diagnóstico de la evaluación y el nivel de riesgo en este caso?

La situación se objetiva como autolesiones sin fines suicidas y el riesgo suicida es bajo ya que la paciente pudo expresarse, colaboró y se mostró reflexiva durante la entrevista, se pudieron identificar posibles causas y no presentaba antecedentes de consumo de sustancias ni otras comorbilidades psiquiátricas. Cabe destacar que la alianza terapéutica y el clima de confianza que generó el profesional posibilitaron la evaluación.

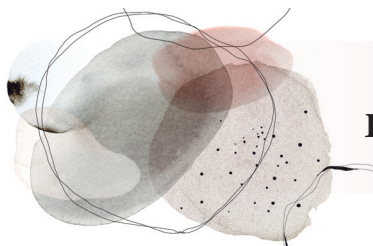
✓ ¿Cuál es la intervención a seguir por el profesional tratante?

El profesional definió que no era necesaria la internación hospitalaria indicando la pronta evaluación ambulatoria por un equipo de salud mental y realizó la derivación.

2 meses más tarde ...

Macarena volvió a consultar por guardia, acompañada por su madre. Fue derivada por el psicólogo tratante quien identificó que presentaba ideas suicidas, ideas de desesperanza y refería estar cansada de todo. En esta ocasión se negó a hablar con el profesional de guardia, mostrándose poco colaboradora en la entrevista y solo pudo comentar, que falleció de manera inesperada su abuela con quien compartía su día a día y que tenía un plan suicida y no quiso revelar mayores detalles.

✓ ¿Cómo varió el riesgo? y ¿cuál sería la conducta en esta nueva consulta?



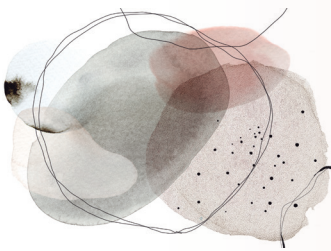
El riesgo es dinámico y requiere reevaluación.

En este caso, se identifican factores de alto riesgo como el empeoramiento del estado de salud mental, la reticencia de la paciente, la ideación suicida y la aparición de planificación suicida. Ante esta situación, se decidió la internación de la paciente quien fue ingresada en la unidad de psiquiatría de adolescentes dado el elevado riesgo de suicidio.

✓ ¿Qué debemos conocer sobre adolescencias y suicidio?

La conducta suicida es una problemática actual en la población adolescente y es uno de los motivos de consulta de urgencia más frecuente en los diferentes niveles de atención. Presenta un espectro, de menor a mayor gravedad, debe distinguirse entre: **ideación suicida, amenazas de suicidio, intentos y, por último, suicidio consumado.**

El suicidio es un **grave problema de salud pública**, siendo la prevención del suicidio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un imperativo universal. Según datos de la OMS el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. Se describe un incremento de los casos conforme aumenta la edad, alrededor del 77% de los casos se registran entre los 15 y 19 años. Afecta a países y personas de diferente nivel socioeconómico, y se estima que aproximadamente el 70% de los que fallecen por suicidio cumplen criterios de algún trastorno psiquiátrico, principalmente depresión y trastorno bipolar. El consumo de alcohol y otros tóxicos facilita el paso a la acción, y el acceso a las armas también supone un factor de riesgo. Se estima que una de cada 10 personas que cometen un intento de suicidio llega a fallecer por esta causa.



Argentina comparte los datos epidemiológicos a nivel global. Según los datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS, 2018) el suicidio en la población de adolescentes de 10 a 19 años es la segunda causa de muerte.

✓ ¿Cómo se define el intento de suicidio? y ¿Cuál su frecuencia?

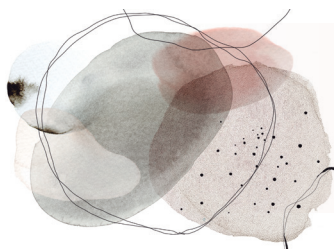
El intento de suicidio se define como aquel acto por el que un individuo se produce de forma deliberada un daño sin resultado de muerte.

Es más frecuente en población femenina (3:1) y se estima que el 10% de los adolescentes intentan suicidarse y cometerían suicidio en los diez años siguientes al intento. Los que llegan a consumar el suicidio son los que utilizan métodos de alta letalidad (armas de fuego, ahorcamiento), los que intentan en forma repetida y los que tienen alto nivel de planificación. Es más elevado en aquellos que han tenido autolesiones no suicidas. El 70% de las personas que presentan autolesiones no suicidas, han intentado suicidarse una vez y el 55% lo ha intentado varias veces.

✓ ¿Cuáles son los métodos de intento de suicidio?

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) **la asfixia, las armas de fuego, la intoxicación con drogas y alcohol y el envenenamiento con plaguicidas y productos químicos son los cuatro métodos más utilizados y representan el 91% de todos los suicidios en la Región.**

En los niños y niñas los métodos elegidos dependen de la disponibilidad, pueden ser veneno agrícola, kerosene, lesiones en la piel, tirarse, ahorcamiento, fuego y corte de vasos sanguíneos. En adolescentes puede ser ahorcamiento, arma de fuego, sobre ingesta medicamentosa, lesiones autoinfligidas, intoxicación con drogas o alcohol y envenenamiento.



La sobre ingesta medicamentosa en pacientes con alteraciones de la salud mental es la causa más frecuente de consulta en los servicios de urgencias.

✓ ¿Cómo realizar la evaluación en la guardia de un intento de suicidio?

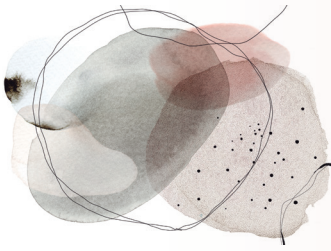
- 1) **Realizar Triage:** Determinar tipo/tiempo de atención.
- 2) **Evaluación clínica y estabilización:** realizar examen físico completo; observar probables signos de abuso sexual y/o maltrato; pesquisa de signos físicos de ingestión y/o abuso de sustancias psicoactivas u otras sustancias tóxicas; embarazo; estado de conciencia y evaluación del estado psíquico global.
- 3) **Tratamiento médico habitual** de los síntomas físicos y/o lesiones si las hubiera, y al abordaje de los síntomas psíquicos que se presenten en la urgencia, priorizando la intervención verbal.

✓ ¿Cuáles pueden ser las conductas a seguir según el resultado de la valoración inicial?

- A) Si no se encuentra en condiciones clínicas y presenta alteración de funciones psíquicas: se prioriza la estabilización clínica. Una vez estable, se solicitará interconsulta con el equipo de salud mental para evaluar riesgo suicida e instaurar tratamientos.
- B) Si se encuentra lúcido y clínicamente estable se procederá a realizar entrevista dirigida con el fin de evaluar riesgo suicida y determinar tipo de intervención. También se puede sumar escalas para evaluar riesgo, no reemplazan a la entrevista clínica.

✓ ¿Con qué herramientas contamos para evaluar el riesgo suicida?

- A) **ASQ** (escala de detección de riesgo de suicidio). Se administra mediante una entrevista dirigida. Con una **respuesta positiva** es suficiente para realizar una entrevista más extensa.
 - ✓ En las últimas semanas ¿has deseado estar muerto?
 - ✓ En las últimas semanas ¿has sentido que vos o tu familia estarían mejor si estuviera muerto?
 - ✓ Durante las últimas semanas ¿has tenido pensamientos de suicidarte?
 - ✓ ¿Alguna vez has intentado suicidarte?
- B) **Entrevista clínica:** a realizar por quien reciba al paciente.



IMPORTANTE: Ambiente privado y seguro (no elementos punzo cortantes, no accesibilidad a fuga, no vidrios), entrevistador empático y tranquilo. En caso de los adolescentes se sugiere tener una primera entrevista con él y luego recabar información con familiares o referentes afectivos. Se evaluará en función de la situación clínica y emocional del adolescente. Antes y luego de la entrevista el niño/a o adolescente debe permanecer con acompañamiento continuo por referente afectivo en habitación segura.

✓ ¿Qué información se debe recabar en la entrevista para definir los pasos a seguir?

- ✓ Letalidad del método: alta o baja.
- ✓ Planificación del acto: ¿Hace cuánto que venís pensando en terminar con todo?
- ✓ Existencia de un plan minucioso.
- ✓ Escritura de notas o cartas que no pudieran ser encontradas fácilmente.
- ✓ Existencia de un plan reiterado en el tiempo, que fue planificado antes y no concretado o fallido.
- ✓ Circunstancias en la que se concretó el plan ¿con quién estabas cuando realizaste el intento? ¿se lo habías comentado a alguien?
- ✓ No amenazó ni presentó ninguna actitud que pudiera advertir a alguien.
- ✓ Estaba solo/a cuando ejecutó el plan y/o no avisó a nadie luego.
- ✓ Lo llevó a cabo en circunstancias que hacían difícil la interrupción y/o el rescate.
- ✓ Procuró el tóxico o el elemento riesgoso y lo guardó un tiempo hasta ejecutar el plan.
- ✓ Grado de impulsividad ¿Qué había pasado antes de que realices el intento?
- ✓ Sin la posibilidad de reflexión, generalmente en un contexto de conducta disruptiva y/o violenta y de manera tan abrupta que hace imposible o dificulta su interrupción por otros/as.
- ✓ La impulsividad es considerada un factor de riesgo en sí misma, ya sea porque la acción tiene evidente y manifiesta intencionalidad suicida, o por estar conducida a aliviar tensiones psíquicas intolerables.
- ✓ Actitud y afecto posterior al intento: No procura asistencia. Trata de impedir o dificultar su rescate. No manifiesta arrepentimiento o alivio por haber fallado, sino irritabilidad por haber sido asistido/a o interrumpido/a. Se muestra indiferente o con poca conciencia del riesgo al que se expuso.
- ✓ Estado psíquico al momento de la consulta: obnubilación o confusión. Excitación psicomotriz, agresividad. Expresión manifiesta de planes autoagresivos. Ideación implícita de autolesión, de muerte y/o suicida. Desesperanza, baja autoestima, desinterés

generalizado, tristeza. Incapacidad manifiesta o inferible para el manejo de sus afectos. Aislamiento y dificultad severa para vincularse afectivamente. Otros síntomas psíquicos tales como: desinhibición, alucinaciones injuriosas, ideas delirantes de auto referencia, grandiosidad o místicas de sacrificio, insomnio, impulsividad.

- ✓ Intoxicación o consumo agudo de alcohol u otras sustancias psicoactivas.
- ✓ Acción autolesiva repetida e intentos previos.
- ✓ Presencia de problemática de salud mental previa: depresión, manía, hipomanía, impulsividad, esquizofrenia.
- ✓ Antecedentes de tratamiento de salud mental: internaciones, tratamientos interrumpidos, etc. Evento y/o situación estresante desencadenante del acto o ideación. Muerte o enfermedad grave recientemente diagnosticada a un/a familiar, referente o amigo/a. Abuso sexual y/o maltrato. Conflictos intrafamiliares graves (separaciones y otros). Conflictos con pares, rupturas sentimentales. Dificultades y/o fracasos en el ámbito escolar.
- ✓ Existencia de patología orgánica grave, crónica y/o terminal: diabetes, VIH, patología oncológica, enfermedades sistémicas, autoinmunes, neurodegenerativas, etc.
- ✓ Vulnerabilidades asociadas al contexto socio familiar: facilitación o inducción explícita o implícita por parte del/a adulto/a. Actitud desinteresada o negligente del/a adulto/a frente al hecho: minimizar el riesgo, no consultar rápidamente, considerar que está fingiendo o simplemente llamando la atención, etc. Historia familiar de suicidios consumados y/o intentos. Historia familiar de problemáticas de salud mental, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual y/o maltrato. Existencia de patología grave, crónica y/o terminal en algún miembro familiar. Red familiar actual insuficiente o poco continente. Aislamiento: inexistencia o insuficiencia de red social de pares. Ámbito escolar incontinente o pérdida de escolaridad. Acoso escolar (bullying) o ciberacoso. Antecedentes de suicidios consumados y/o intentos en grupo de pares. Autoagresión como modalidad habitual en grupo de pares. Pertenencia a un sistema de creencias personales, familiares y/o sociales que exaltan la muerte. Situación de vulnerabilidad socioeconómica.

✓ ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas inmediatas?

- A) Internación.
- B) Permanencia en servicio de guardia.
- C) Sala del hospital polivalente para observación.

Se recomienda realizar la evaluación por profesional de Salud Mental en un lapso no mayor a las 48 horas (dependiendo de la accesibilidad a la consulta con especialista). Ante la ingesta de tóxicos o fármacos es importante practicar las medidas de desintoxicación y eliminación según las sustancias involucradas (cantidad, farmacocinética, riesgo de vida etc.), el tiempo post ingesta, la disponibilidad de antídotos y dosajes posibles.

✓ ¿Cuáles son los criterios de ingreso hospitalario?

Alto riesgo de suicidio. Luego de una evaluación integral, se considera que una de las siguientes es suficiente para indicar internación:

Características de la conducta suicida	• Alta letalidad (arma de fuego, ahorcamiento). • Alta intencionalidad suicida. • Persistencia de la ideación suicida o decepción por el fracaso del intento de suicidio. • Agitación, irritabilidad, impulsividad. • Actitud amenazante. • Intento de suicidio que incluía pasos para evitar la detección.
Existencia de trastornos psiquiátricos	• Sintomatología psicótica. • Depresión moderada/grave. • Manía. • Consumo de sustancias psicoactivas. • Desesperanza grave. • Antecedentes de intentos de suicidio o de autoagresión del/a adolescente, o intento de suicidio de personas cercanas.
Características del contexto familiar o social	• Maltrato. • Trastorno psiquiátrico grave de los padres. • Familia incapaz de controlar la situación. • Dificultades para llevar a cabo un seguimiento y tratamiento adecuado. • Antecedentes de abandono de tratamiento ambulatorio psiquiátrico.

Bajo Riesgo. En caso de evaluarse esta situación, se puede realizar una intervención en guardia con escucha activa, orientación al paciente y su familia, alta institucional y derivación para continuar el tratamiento en ámbito ambulatorio por salud mental.

Podemos decir que bajo riesgo se refiere, a que la acción autolesiva es de bajo grado de agresión; la ideación con poca consistencia, el contexto familiar se evalúa como continente y los/as referentes vinculares presentan una actitud de compromiso para adoptar medidas de cuidado, y el/la adolescente se muestra de acuerdo con la necesidad de continuar el tratamiento y puede garantizarse el seguimiento.

Con evaluación **toxicológica positiva** y en todos los casos que se haya presentado ingesta de tóxicos, el alta es con un paciente asintomático, con parámetros de laboratorio y estudios complementarios que no requieran seguimiento hospitalario.

La indicación de salud mental, al alta contempla la coordinación del seguimiento por un equipo interdisciplinario de Salud Mental. Es de buena práctica, al alta tener certeza del turno para Salud Mental dentro de los siete días subsiguientes, especificando fecha y hora del turno y nombre del/a profesional, e indicar acompañamiento permanente de un/a referente afectivo adulto/a. Es sabido, que suelen haber demoras importantes en atención en salud mental y, en caso de no estar garantizada e interrumpirse la continuidad de tratamiento, podría poner en riesgo al paciente.

Tabla 2. Suicidio ¿Mito o realidad?

MITO	REALIDAD
El/la que dice o amenaza con que se va a matar, no lo hace	Se ha demostrado que la mayoría de las personas que cometen suicidio tuvieron un intento anterior, dieron algún aviso o comunicaron sus intenciones. Por lo tanto, no se deben minimizar estas advertencias y es necesario intervenir oportunamente para prevenir.
El/la que se suicida está atravesando una depresión	Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros trastornos mentales, además de comportamientos destructivos y agresivos. Sin embargo, esta asociación no se debe sobrestimar. La proporción relativa de estos trastornos varía en distintos sitios y hay casos en los que no había ningún trastorno mental evidente.
Hablar con una persona sobre sus intenciones de matarse incrementa el peligro	Es necesario hablar con los/as adolescentes sobre sus intenciones de matarse. El peligro es que éstas se mantengan ocultas. En realidad, la validación del estado emocional de la persona y la normalización de la situación inducida por la tensión son componentes necesarios para reducir la ideación suicida.
El suicidio no se puede prevenir porque ocurre por impulso, sucede sin advertencia	Muchas personas dan algún tipo de indicación verbal o conductual acerca de sus intenciones de hacerse daño, por los que es necesario destacar la posibilidad de prevención del suicidio y no estimarlo como un acto inevitable.
El/la que intenta suicidarse es un/a cobarde o un/a valiente	Es necesario no catalogar los actos suicidas desde una perspectiva moral obturando el sentido que trae consigo esta problemática. Es preciso trabajar en contra de estas sentencias.
Los/as niños/as no se suicidan	Aunque es poco común, los/as niños/as, a partir de que incorporan el concepto de la muerte y su irreversibilidad, sí pueden cometer suicidio y cualquier gesto, a cualquier edad, se debe tomar en serio.
La tendencia al suicidio es hereditaria	No todo suicidio se puede relacionar con la herencia y los estudios concluyentes son limitados. Sin embargo, el historial familiar de suicidio es un factor de riesgo importante de comportamiento suicida, particularmente en familias en que el suicidio aparece como opción frente a situaciones problemáticas.
Las personas con riesgo de suicidio tienen toda la intención de matarse	Muchas personas mantienen una ambivalencia con respecto al acto suicida. No siempre su intención de matarse es irrevocable y/o plenamente consciente.
La mejoría después de una crisis significa que el riesgo de suicidio ha desaparecido	En realidad, uno de los momentos más peligrosos es inmediatamente después de la crisis o cuando la persona está en el hospital después de un intento de suicidio. La semana después del alta es cuando la persona está particularmente frágil y en peligro de hacerse daño. Puesto que el comportamiento pasado es pronóstico del comportamiento futuro, sigue estando en situación de riesgo. Es necesario garantizar un seguimiento centrado en la persona.
No todos los suicidios pueden prevenirse	Si bien eso tiene un punto de verdad, la mayoría de los casos se pueden prevenir realizando intervenciones adecuadas.
Una vez que una persona es "suicida", lo es para siempre	La estigmatización es uno de los graves problemas que afectan a las personas que realizaron un intento de suicidio, o que tuvieron alguna ideación, aislándolas aún más y aumentando su vulnerabilidad. Se aconseja no usar etiquetas como "suicida" y pensar la problemática como algo transitorio que está atravesando el sujeto, garantizándole la posibilidad de una mejoría.

Fuente: *Abordaje integral del suicidio en las adolescencias: lineamientos para equipos de salud* / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación; Sociedad Argentina de Pediatría; UNICEF, 2021.

DIEGO, 16 AÑOS

Ingresa a guardia con cuadro de excitación psicomotriz, desorientación temporo-espacial, alucinaciones visuales, taquicardia, hipertensión e hipertermia. Concorre acompañado por una amiga quien refiere que estaban en un boliche de música electrónica. Relata, consumo de alcohol, “rolas”, cannabis y “pepa” (drogas sintéticas consumidas en fiestas electrónicas).

✓ ¿Qué conductas tomamos ante este cuadro?

Se decide realizar laboratorio que incluye medio interno y CPK, se constata hiponatremia y rabdomiolisis. Evaluación cardiológica con ECG que informa taquicardia sinusal.

Se asume el cuadro como **síndrome serotoninérgico**, se indica hidratación parenteral, corrección del medio interno. Uso de medios físicos para la hipertermia y benzodiazepinas para la excitación psicomotriz.

Ante un paciente con riesgo de vida siempre se cita al adulto responsable, padre, madre o tutor.

✓ ¿En qué sustancias pensamos?

Este cuadro suele asociarse al consumo de drogas de síntesis, nuevas sustancias psicoactivas (NPS), cannabis y asociado a abuso de psicofármacos. La anamnesis dirigida es fundamental para el diagnóstico dado que la mayor parte de las sustancias sintéticas no se detectan en screening.

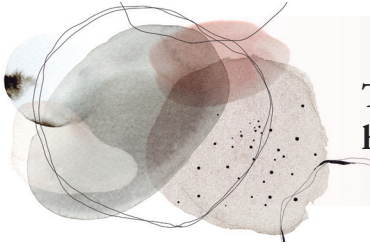
✓ ¿Qué observamos y evaluamos frente a un paciente en la guardia con un cuadro de intoxicación o abstinencia? ¿Qué signos buscamos en la exploración?

Ante todo, el control de **signos vitales** (frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura corporal) estado y reacción pupilar (midriasis, miosis anisocoria), sensorio, tono muscular, amplitud de pulsos. Hay que descartar cuadros vinculados a traumatismos dado que el consumo de sustancias puede acompañarse de situaciones de violencia y lesiones no intencionales (accidentes), etc. El examen físico exhaustivo nos dará la posibilidad de encuadrar el toxindrome.

✓ ¿Cómo se realiza la evaluación del estado psíquico global en urgencias de salud mental y/o toxicológica?

Para iniciar la evaluación del estado psíquico se recomienda observar y describir las siguientes funciones:

Estado de conciencia: Es el conocimiento del entorno, del cuerpo y de sus vivencias. El paciente puede llegar despierto o dormido. También se evalúa el curso del nivel de conciencia. Existen diferentes grados del estado de conciencia: somnolencia, hipoalerta, vigilia normal o hiperalerta. Se evalúa también la forma de inicio en toda alteración del nivel de conciencia.



Toda alteración que ocurre en forma abrupta es orgánica hasta que se demuestre lo contrario.

Estas alteraciones agudas de la conciencia se clasifican de la siguiente manera:

Trastornos cuantitativos de la conciencia	Obnubilación	Disminución del estado de conciencia. Tiene reducida la capacidad de captación del entorno. Puede alternar con episodios de excitación y tener raptos de ira impulsiva.
	Estupor	Mayor grado de desconexión (estupor psiquiátrico tiene sensorio conservado, EEG normal y reflejos conservados a diferencia del neurológico). El estupor fluctúa entre el enlentecimiento y la inmovilidad hasta llegar a cuadros más graves del espectro catatónico.
	Sopor	Inconsciente, pero responde a estímulos de mayor intensidad, tiene respiración rítmica y lenta.
	Coma	No responde a ningún estímulo, no hay reflejos y la respiración es desordenada.
Las sustancias vinculadas a este cuadro clínico son los depresores del sistema nervioso central siendo el alcohol la sustancia más involucrada en el consumo problemático y la sobreingesta de psicofármacos.		
Trastornos cualitativos de la conciencia	Fluctuación de la conciencia	Puede variar de hora en hora en relación a oscilaciones del nivel de atención y vigilia. Siempre sospechar cuadros orgánicos cuando hay fluctuaciones de los estados de conciencia.
	Confusión	Cuando el pensamiento no es claro y se pierden encadenamientos lógicos y sintácticos (incoherencia).
	Atención, percepción y memoria	Deben estar conservadas para referir que el paciente presenta lucidez de conciencia.

A través de la **anamnesis** podemos evaluar las dimensiones neuropsicológicas más importantes:

- 1. Sensorio:** Es la capacidad de estar orientado en tiempo, lugar y persona. En cuadros de intoxicaciones se puede encontrar al paciente con desorientación tiempo-espacial.
- 2. Atención:** Es el grado con el que el paciente percibe los estímulos para orientarse y actuar eficazmente. Hiperprosexia es cuando está excesivamente atento, se ve en pacientes que presentan ideas paranoides por consumo. Si el paciente no puede prestar atención no se puede evaluar la memoria. En encefalopatías tóxicas puede observarse inatención severa que dificulta la evaluación.

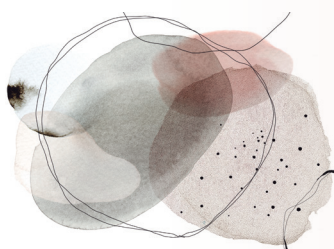
- 3. Conducta motora:** El paciente puede estar cursando un cuadro de agitación psicomotriz donde se produce aumento de frecuencia e intensidad de todos sus movimientos. En cuadros más leves se puede ver hiperactividad. En cuadros graves de agitación motora se acompaña del compromiso del nivel de conciencia, la agitación motora dificulta el control verbal, esto conlleva riesgos de agresividad para sí y/o terceros.
- 4. Lenguaje:** Se evalúa el volumen, claridad, entonación, perseverancia, fuga de ideas. En general en los cuadros neurológicos se altera más frecuentemente la articulación del habla y lenguaje, en los psiquiátricos se altera el discurso. Hay cuadros de verborragia o taquilalia (aumento de la velocidad) o hipolalia (lentitud). Ambas pueden darse en cuadros de intoxicación y depende del tipo de sustancia. Los benzodiazepinas y el alcohol se asocian a disartria mientras la cocaína y otros estimulantes a la verborragia.
- 5. Emocionalidad:** Se deberá evaluar si es acorde a la situación que atraviesa el paciente, su estado de ánimo, depresivo, enojado, temeroso. Evaluar intensidad y labilidad.
- 6. Memoria:** Evaluar memoria reciente (captar, retener y reproducir) y remota (evocar e identificar). Pueden presentar amnesia anterograda y retrograda. Se evalúa haciendo preguntas al paciente sobre hechos actuales y pasados.
- 7. Pensamiento:** Se evalúa si es coherente, si tiene lógica, si sigue una idea directriz, como es la asociación de ideas, si presenta un bloqueo y no puede continuar. Trastornos del curso y contenido del pensamiento. La taquipsiquia es el aumento de la expresión verbal con aumento de la velocidad y sucesión de palabras. En su máxima expresión se observa fuga de ideas (trastorno del curso del pensamiento). El consumo de cocaína y estimulantes se asocia a taquipsiquia y alteración del pensamiento aumentando con ideas delirantes y delirio persecutorio.
- 8. Trastornos de la percepción:** Las alucinaciones visuales, auditivas o táctiles sin presencia del objeto real, distorsión de la percepción corporal. Ilusiones: percepciones deformadas de un objeto que existe en la realidad. Despersonalización (percibir cambios en el esquema corporal). Desrealización (percibir cambios en el ambiente). El consumo de empatógenos, psicodélicos disociativos y cannabinoides se vinculan a estos síntomas.
- 9. Juicio:** Es la capacidad de captar situaciones, evaluarlas y seleccionar formas apropiadas de acción. Tienen que estar conservadas todas las facultades previamente desarrolladas para el juicio adecuado. En los cuadros de intoxicación el juicio se encuentra suspendido, si tiene un cuadro confusional o desviado por un cuadro psicótico por consumo.
- 10. Otras funciones a evaluar:** Ritmos circadianos, rutinas y hábitos. Es muy importante tener una anamnesis detallada sobre el sueño y la alimentación.

✓ ¿Cómo abordamos al paciente que consume?

Armado de equipo evaluador del paciente: psicopatología, asistencia social y las especialidades clínicas que se encuentren involucradas (cardiología, ginecología, Infectología, etc.)

- Evaluación de **situación de riesgo** y si el consumo es **problemático o esporádico**.
- Paciente **asintomático** sin riesgo cierto e inminente, seguimiento ambulatorio.
- Paciente **sintomático** se interna hasta estabilizar y evaluar tipo de consumo. Derivación al alta según el caso.

Según la sustancia utilizada, hacer controles de laboratorio y otros estudios complementarios. Recordar que no existe una cantidad de sustancia que sea segura durante el embarazo y lactancia.



Al alta se da turno para seguimiento por equipo interdisciplinario de los servicios de adolescencia, salud mental y toxicología. También requiere armado de red en sistema de salud con la familia y entorno.

Aunque en niños y adolescentes el consumo sugerido es cero es importante poder acompañar a los pacientes y abordar las problemáticas tanto en consumo de sustancias como en las adicciones comportamentales que aumentaron mucho durante y post pandemia.

✓ ¿Qué estrategias son útiles para la atención en urgencias?

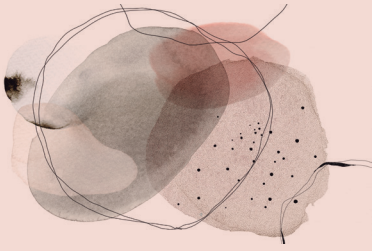
Cuando los antecedentes y detalles del paciente se desconocen, para poder abordar su atención se busca **encuadrar el cuadro clínico con algún toxindrome** (síntomas y signos de intoxicación o abstinencia) vinculados a diferentes tóxicos que se abordan de manera específica, aunque no se conozca la sustancia en particular involucrada.

El uso de screening de sustancias no suele estar disponible y no abarcan la mayor parte de las sustancias por lo cual la clínica es soberana a la hora de pensar un tratamiento en la urgencia.

Toxindromes vinculados a:

Excitación psicomotriz	A. Síndrome simpaticomimético. B. Síndrome anticolinérgico. C. Síndrome serotoninérgico. D. Síndrome alucinógeno (Delirio agitado).
Depresión del sensorio	A. Síndrome opioide o narcótico. B. Síndrome sedativo hipnótico.
Otros Toxindromes	A. Síndrome Extrapiramidal. B. Síndrome neuroléptico maligno.

Desarrollaremos algunos toxindromes en el ANEXO 1.



Autoevaluación

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados.

V F

1. Una urgencia psiquiátrica es una crisis que implica una ruptura del equilibrio vital y se define por la necesidad de un tratamiento inmediato por situaciones de sufrimiento psíquico con alteraciones agudas y graves. ☐ ☐
2. En la guardia, lo primero que hay que hacer es la evaluación de salud mental para decidir si es necesario internar al paciente. ☐ ☐
3. Cuando un episodio de excitación psicomotriz (EPM) está vinculado a sustancias se debe sospechar consumo de: cocaína, metanfetaminas, nuevas sustancias psicoactivas (NSP), anfetaminas, cannabinoides sintéticos o cannabis con elevada concentración de tetrahidrocannabinol (THC). ☐ ☐
4. Una de las primeras medidas ante un paciente con EPM es evaluar si existe riesgo cierto e inminente y tomar las medidas de seguridad apropiadas para el paciente y el profesional de la salud ya que solo se debe proceder cuando esté garantizada la seguridad del profesional. ☐ ☐
5. En Argentina el suicidio en la población de adolescentes de 10 a 19 años es la segunda causa de muerte. ☐ ☐
6. La indicación de salud mental, al alta contempla la coordinación del seguimiento por un equipo interdisciplinario de Salud Mental. ☐ ☐
7. El 90% de las personas que se suicida está atravesando una depresión grave. ☐ ☐
8. Ante un niño, niña o adolescente con riesgo de vida, independientemente de su edad, siempre se cita al adulto responsable, padre, madre o tutor. ☐ ☐
9. Las alucinaciones son un cuadro extremo de excitación psicomotriz asociado a sustancias que constituyen una emergencia médica que, de no ser tratada, puede provocar la muerte del paciente. ☐ ☐
10. El síndrome opioide o narcótico tiene un antídoto que es la fisostigmina. ☐ ☐



CONCLUSIONES

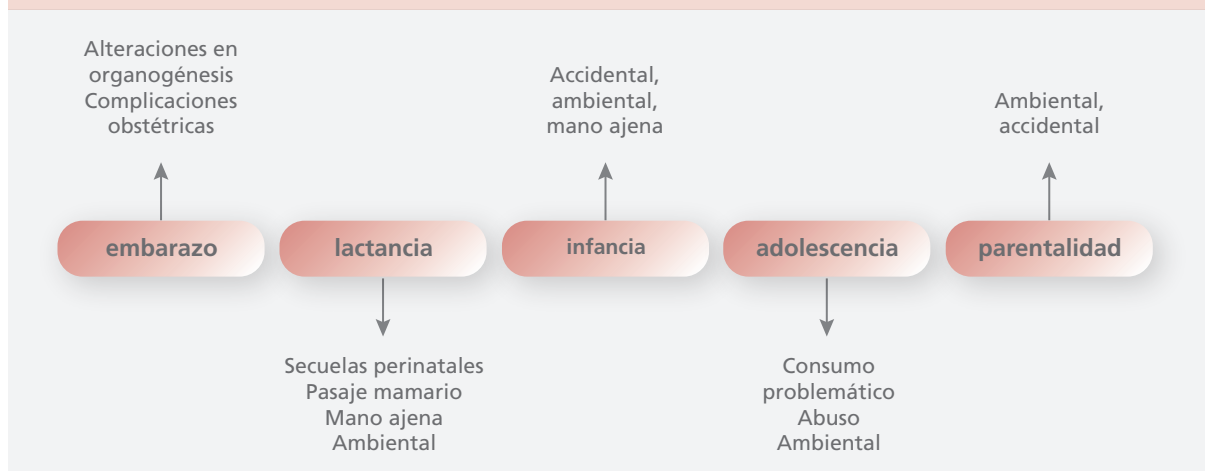
Las urgencias psiquiátricas y toxicológicas en la infancia y adolescencia se pueden presentar en múltiples escenarios asistenciales lo que implica que el personal de salud, independientemente de su expertis, debe brindar los primeros cuidados y estar capacitados para realizar una derivación asertiva.

La anamnesis es la herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de estas patologías en conjunto con un minucioso examen clínico que complementa la evaluación llegando así a un diagnóstico integral que permite descartar otras entidades solapadas por el tipo de presentación. Las sustancias que se consumen con más frecuencia son **alcohol, bebidas energizantes, tabaco y cannabis** siendo esta última la que va en ascenso en los últimos años. Con descenso en la edad de inicio de consumo y baja percepción de riesgo tanto en jóvenes como en adultos.

Nos interesa alertar al Equipo de Salud sobre dos problemáticas que hemos observado, el consumo parental y la baja percepción de riesgo sobre el consumo de sustancias.

- ✓ **El consumo parental** que trae aparejado múltiples riesgos y consecuencias como
 - Pasaje mamario y placentario - Fumador pasivo - Intoxicaciones accidentales - Mayor riesgo a accidentes por descuido - Deterioro del vínculo con los hijos - Mayor predisposición a consumo en descendencia, por lo cual debemos tenerlo en cuenta y el consumo debería estar presente en la anamnesis de diferentes especialidades.

Figura 1. Presentación clínica asociada a sustancias psicoactivas en Htal. Pediátrico



- ✓ En la **Encuesta Nacional sobre Consumo y Practicas de Cuidado 2023** (EN-CoPrac) INDEC. Se describe una **baja en la percepción de riesgo sobre el consumo** de sustancias particularmente de cannabis en las clases con mayor nivel educativo, el consumo en hogares propios y de amigos de los adultos, hecho que lleva a pensar con más frecuencia a las intoxicaciones accidentales en los hogares y mayor tolerancia por parte de los adultos al consumo adolescente.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Alda Díez JA, Fraile SG. Urgencias Psiquiátricas en el niño y el adolescente. 2006. Madrid Masson S.A.
- Carandang C, Gray C, Marval-Ospino H, MacPhee S. Urgencias Psiquiátricas en Niños y Adolescentes. En Rey JM (ed), Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP. 2018. Ginebra: Asociación Internacional de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y Profesiones Afines.
- Falcoff A., Fantin JC. Manual de Clínica y Terapéutica en Psiquiatría Argentina. 2009. Letra Viva.
- Morer Liñán, A. Urgencias en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia: ¿Dónde está el límite? Revista De Psiquiatría Infanto-Juvenil, 2023; 40(1), 1–3.
- Paula Vázquez López, et al. Autolesiones y conducta suicida en niños y adolescentes. Anales de Pediatría. 2023; 98(3), 204-212.
- Argentina. Ministerio de Salud de la Nación. Lineamientos para la atención del consumo episódico excesivo de alcohol en adolescentes. 2020.

ANEXO 1

CUADROS ASOCIADOS A LA EXCITACIÓN PSICOMOTRIZ

A. El síndrome simpaticomimético se caracteriza por presentación de taquicardia, hipertensión, midriasis, hipertermia y excitación psicomotriz.

Las sustancias que generan este cuadro son las que aumentan la disponibilidad de noradrenalina por ejemplo la cocaína, las anfetaminas, etc. Otras sustancias andrógenos, hidrocarburos.

El manejo de este paciente es con sedación en primera instancia con benzodiacepinas y de persistir la excitación psicomotriz el uso de neurolépticos atípicos como la olanzapina. Control de TA con nitritos nunca con betabloqueantes y ante evento isquémico miocárdico se debe usar nitroglicerina.

B. El síndrome anticolinérgico se presenta clínicamente como excitación psicomotriz con taquicardia, midriasis, sequedad de mucosas, retención urinaria, rubicundez, hipertermia, alucinaciones, y disminución de ruidos hidroaéreos. Se asocian al uso de atropina y similares, ciclopentolato, antihistamínicos, meperidina, fenotiazinas, antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos, amanita muscaria y plantas alucinógenas (solanáceas: floripondio, chamico, mandrágora, beleño), cannabis y cannabinoides sintéticos. Ante este cuadro lo importante del tratamiento es descender la temperatura del paciente, sedarlo con benzodiacepinas y con la persistencia del cuadro clínico el antídoto específico es la fisostigmina (contraindicado si existe alergia a colinérgicos, o ante sobredosis de antidepresivos). Dosis de Adulto 0,5 a 2 mg EV lento (5 minutos). Dosis pediátrica 0,02 mg/Kg a 2 mg EV lento (5 minutos).

C. El síndrome serotoninérgico se caracteriza por alteración del estado mental, hiperreflexia, rigidez, inestabilidad autonómica (HTA, taquicardia, diarrea, sialorrea), clonus. Se presenta clínicamente como excitación psicomotriz con taquicardia, midriasis, sequedad de mucosas, retención urinaria, rubicundez, hipertermia, alucinaciones, y disminución de ruidos hidroaéreos.

Los medicamentos asociados a este cuadro son:

Inhibidores de recaptación de serotonina	sertralina, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram.
Antidepresivos	trazodona, nefazodona, buspirona, clomipramina, venlafaxina.
Inhibidores de monoaminoxidasa	fenelcina, moclobemida, clorgilina, isocarboxazida, amitriptilina, nortriptilina.
Antipsicóticos	risperidona, olanzapina.
Anticonvulsivantes	valproato.
Opioides	meperidina, fentanilo, tramadol, pentazocina.
Agentes antieméticos	ondansetron, granisetron, metoclopramida.

Antimigrañosos	sumatriptan.
Antiparkinsonianos	selegilina, sibutramina.
Antibióticos y antivirales	linezolid, eritromicina, ritonavir, saquinavir, efavirenz.
Antitusígenos	dextrometorfano.
Drogas ilícitas	metilendioximetanfetamina (éxtasis), dietilamina del ácido lisérgico (LSD), 5-metoxi diisopropil triptamina, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, catinonas y otras nuevas sustancias psicoactivas (NPS) cannabis y cannabinoides sintéticos.
Suplementos dietéticos y productos herbales	triptófano, ginseng, tianeptina.
Otros	litio, buspirona, tandospirona. También asocian al uso de drogas como atropina y similares, ciclopentolato, antihistamínicos, meperidina, fenotiazinas, antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos, amanita muscaria y plantas alucinógenas (solanáceas: floripondio, chamico, mandrágora, beleño).

Se debe solicitar laboratorio con medio interno, CPK, función hepática y renal, sedimento urinario. ECG.

Los criterios diagnósticos son: adición de un agente serotoninérgico o aumento de sus dosis y aparición de al menos, cuatro síntomas mayores o tres mayores y dos menores.

Nivel de conciencia y conducta:

Síntomas mayores: coma, confusión, hipertermia, excesiva activación anímica.

Síntomas menores: agitación, nerviosismo, insomnio, síntomas autonómicos.

El tratamiento ante la aparición del cuadro lo importante es descender la temperatura del paciente, sedarlo con benzodiacepinas y con la persistencia del cuadro clínico el **antídoto específico** es la fisostigmina (contraindicado si existe alergia a colinérgicos, o ante sobredosis de antidepresivos). Dosis de adulto 0,5 a 2 mg EV lento (5 minutos). Dosis pediátrica: 0,02 mg/Kg a 2 mg EV lento (5 minutos).

D. Las alucinaciones – delirio agitado es un cuadro extremo de excitación psicomotriz asociado a sustancias. Presenta un conjunto de signos y síntomas que incluyen comportamiento violento, agitación, confusión mental (alucinaciones) delirio, hipertermia e impermeabilidad al dolor durante un corto período que suele asociarse a consumo de cocaína, anfetaminas, catinonas, metanfetaminas y las nuevas sustancias psicoactivas (NPS).

Es una emergencia médica que de no ser tratada puede provocar la muerte del paciente. Se presenta como un cuadro psicótico agudo con euforia, confusión, agitación, pensamiento delirante con ideas paranoides y alucinaciones, presentando una actividad física fuera de lo normal con exteriorización de fuerza inusual y desarrollando una conducta agresiva y bizarra.

Se manifiesta clínicamente con hipertermia, acidosis metabólica, rabdomiolisis, falla renal y cardíaca. El tratamiento es sintomático manteniendo hidratación y sedación previa a la contención física siendo las benzodiacepinas los fármacos de primera elección.

CUADROS ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN DEL SENSORIO

A. El síndrome opioide o narcótico se presenta con la tríada clásica de la intoxicación, miosis puntiforme, depresión respiratoria y coma. Este cuadro tiene un antídoto que es la naloxona que se utiliza en los casos en que el paciente presenta coma de origen desconocido para hacer diagnóstico. Este fármaco se encuentra contraindicado en pacientes dependientes dado que genera la aparición de síndrome de abstinencia. La dosis de naloxona es 0,01 mg/Kg en niños y 0,4 a 2 mg en adolescentes.

B. El síndrome sedativo hipnótico se caracteriza por presentarse con bradicardia, hipotensión, miosis, depresión del sensorio, ataxia, bradipsiquia, hipotonía e hipotermia.

Las sustancias asociadas a este síndrome son los depresores del sistema nervioso central como alcohol, benzodiacepinas, barbitúricos, opioides y otras como gabahidroxibutirato. Ante la ingesta de alcohol excesiva se debe asegurar la vía aérea, la oxigenación, compensación hemodinámica, corrección del medio interno y de hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipokalemia. Ante el abuso por consumo se debe agregar vitamina B1: 100 mg, para evitar el síndrome De Wernicke Korsacoff cuando el cuadro se asume como consumo crónico. Mantener la temperatura corporal.

Ante el abuso de benzodiacepinas sin otras drogas y con el paciente en coma puede utilizarse flumazenil, si el paciente no presenta diagnóstico de epilepsia o dependencia a benzodiacepinas. Ante el abuso de barbitúricos mantener la vía aérea y monitoreo dado que su rango terapéutico es muy estrecho. Se debe usar carbón activado seriado ya que presentan circuito enterohepático. Si el involucrado fue fenobarbital puede alcalinizarse la orina. El tratamiento es sintomático.

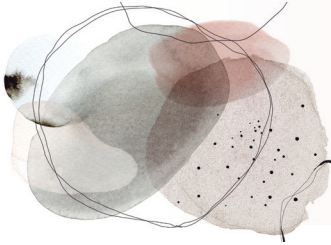
CUADROS ASOCIADOS A OTROS TOXINDROMES

A. El síndrome extrapiramidal se produce por un desbalance entre la dopamina que controla el movimiento (está bloqueada) y la acetilcolina que libera el movimiento a nivel de los ganglios de la base (predominante).

El cuadro clínico es de comienzo agudo, intermitente, repetitivo. La contracción muscular dura segundos a minutos. Nivel de conciencia normal. Afecta cualquier músculo estriado, pero lo típico es músculos oculares y presenta crisis oculógiras con desviación de la mirada hacia arriba; rotación de los ojos y espasmos de los párpados. También puede presentarse en forma de crisis espasmódicas relatadas como convulsiones sin pérdida del estado de conciencia, en cuyo contexto se observa rigidez con aparición de signo de rueda dentada. Las drogas asociadas a este cuadro son los neurolépticos, otros bloqueantes dopaminérgicos como la metoclopramida.

B. El síndrome neuroléptico maligno se caracteriza por tríada clásica, fiebre $>38^{\circ}$, rigidez muscular y alteración de la conciencia. Suele asociarse a cuadros de disautonomía. Se vincula con el uso de neurolépticos o supresión de carbidopa o levodopa. Reacción idiosincrática varía su frecuencia de aparición entre el 0,02 al 12%. Más frecuente en hombres. Puede aparecer con una

sola dosis. El cuadro clínico se desarrolla en 24 a 72 h hasta semanas. Presenta mortalidad de 20 al 30 %, secundaria a fallo respiratorio, colapso cardiovascular, insuficiencia renal aguda, trombo embolismo pulmonar. Alteración de la termorregulación y la afectación de la sustancia nigra produce la rigidez. En el laboratorio se observa leucocitosis, aumento de la CPK y aumento de transaminasas. Hay recurrencia del 30%.



Constituye una emergencia toxicológica y la rapidez a la hora de diagnosticar y tratar a estos pacientes hace al pronóstico evolutivo.

Para hacer el **diagnóstico** se deben cumplir 4 criterios mayores y 3 menores:

Criterios mayores	Uso reciente de bloqueantes dopaminérgicos o suspensión de agonistas como carbidopa o levodopa. Rigidez muscular, hipertermia, alteración del estado mental CPK > de 3 veces su valor normal.
Criterios menores	Otros síntomas extrapiramidales. Inestabilidad autonómica. Dificultad respiratoria. Leucocitosis.

Se debe solicitar laboratorio con hemograma función renal y hepática, CPK, ionograma, sedimento urinario. ECG. El tratamiento es el enfriamiento con medios físicos, la compensación hemodinámica, dantrolene 2,5 mg/kg dosis de ataque y mantenimiento de 1-2,5 mg/kg/dosis cada 6 h el tiempo de tratamiento se verá según el neuroléptico involucrado y la evaluación del paciente. Se asociará con bromocriptina o a benzodiacepinas (DZP) dosis 0,1- 0,3 mg/kg/hora en goteo. Se debe suspender en forma inmediata el neuroléptico involucrado o restaurar el uso de carbidopa o levodopa suspendido. Mantener una hidratación amplia dado que el paciente presenta rabdomiolisis y requiere un amplio aporte de líquidos para evitar la nefritis tubular aguda secundaria al impacto de la mioglobina en el túbulo renal.

CLAVE DE RESPUESTAS

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados.

1. Verdadero.
2. Falso. Antes de la evaluación mental, hay que realizar una valoración médica completa con despistaje de patología orgánica subyacente.
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Verdadero.
7. Falso. Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, sin embargo, esta asociación no se debe sobrestimar. La proporción relativa de estos trastornos varía en distintos sitios y hay casos en los que no había ningún trastorno mental evidente
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Falso. El antídoto es la naloxona que se utiliza en los casos en que el paciente presenta coma de origen desconocido para hacer diagnóstico.